

使いこなす力と疑う力

80% 超

の医師が AI を臨床活用

しか
し…

AI+ 医師 < AI 単独

診断精度 76% vs 90%

AI は味方か、それとも新しい罠か？

— AMA 調査 / IME 2026 / Frontiers in Digital Health 2025

今日の学習目標（45 分）

説明できる

AI の 3 世代とマルチエージェントの概念

分析できる

AI が持つ認知バイアスの種類

判断できる

AI を使うべき場面と逆効果な場面

提案できる

自分の研修に AI をどう組み込むか

AI の進化 — 3 世代

第 1 世代 ルールベース

人間がルールを書く

例：処方チェックシステム

第 2 世代 生成 AI

1 つの AI が何でもやる

例：ChatGPT に症例を聞く

第 3 世代 エージェント AI

専門 AI チームが協力

例：複数 AI が分担して診断支援

マルチエージェント = チーム医療の AI 版

Supervisor Agent (総合医)

検査データ専門

画像診断専門

薬剤相互作用

ガイドライン照合

Mount Sinai 研究の 3 つの発見

精度向上 : マルチエージェントが単一 AI を統計的に有意に上回る

コスト削減 : 計算コストを最大 65 分の 1 に

スケーラビリティ : タスク増加でも性能維持 (単一 AI は低下)

AI が引き起こす認知バイアス

アンカリング

AI の最初の提案に引きずられる

対策

鑑別を自分で考えてから AI に聞く

自動化バイアス

AI が正しいと無条件に信じる

対策

「AI が言ったから」を理由にしない

確証バイアス

AI の答えを支持する情報だけ探す

対策

反証を意識的に探すルーチン

AI を使うべき場面 vs 使うと危ない場面

AI が得意

- 網羅的な鑑別診断リスト
- ガイドラインの確認
- 薬剤相互作用チェック
- 文献検索・要約
- 教育シナリオの生成

AI が危ない

- 未経験の症候の最終診断
- 患者の価値観を踏まえた意思決定
- 文脈依存の臨床判断
- ハルシネーション（もっともらしい嘘）
- 感情的サポートが必要な場面

AI は「考える相棒」であって「判断する主治医」ではない

AI ロールプレイ（15 分）

3 つの役割を体験してみましょう

Patient AI

症例を提示する
(症状・検査結果を段階的に開示)

Socratic AI

考えを深める質問をする
(「なぜそう考えた?」「他には?」)

Red Team AI

意図的に反論する
(「この診断を否定するエビデンスは?」)

3 人 1 組 | 各役割 5 分ずつ | 症例は配布シート参照

ロールプレイの振り返り

AI に引きずられた瞬間はあったか？

「自分で考える」と「AI に聞く」のバランスは？

Red Team の反論で気づきはあったか？

PNAS 2026: AI を使った群は、使わない群より確証バイアスが強くなった
→ 「疑う力」を意識的に鍛える必要がある

AI 活用の 3 つのルール

1

まず自分で考える

鑑別を 3 つ挙げてから AI に聞く
→ アンカリングを防ぐ

2

AI の答えを疑う

「AI が言ったから」を理由にしない
→ 反証を探すルーチン

3

使った過程を記録する

どの場面で AI を使い、どう判断したか
→ ポートフォリオに活かせる

持ち帰りのアクション

今日

次の症例で「まず自分で3つ鑑別」→ AIに聞く、を試す

今週

AIの提案を1回は意識的に疑ってみる

今月

AI活用の経験をポートフォリオに1つ書く

AIは最強の相棒になれる。でも、主治医はあなたです。